BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH THU THẬP, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN MẪU BỆNH PHẨM NGHI NHIỄM COVID-19

Mã hiệu: **VS.PCR.01.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Ths KTV	Biên soạn	**Trần Thị Quy**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn cách thu thập mẫu bệnh phẩm đường hô hấp và bệnh phẩm máu để chẩn đoán SARS-CoV-2

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho các đơn vị thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viên phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Cán bộ Quản lý an toàn sinh học có trách nhiệm đảm bảo nhân viên thực hiện xét nghiệm này tuân thủ quy định an toàn sinh học.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG, TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ sử dụng:

- Virus corona là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng
- SARS-CoV: Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng

Từ viết tắt:

- MTVC: môi trường vận chuyển
- PTN: phòng thí nghiệm

5. BỆNH PHẨM

- Mẫu dịch (bắt buộc):

- Bệnh phẩm đường hô hấp trên: mẫu ngoáy dịch tỵ hầu
- Bệnh phẩm đường hô hấp dưới: đờm, dịch hút nội khí quản, dịch phế nang, dịch màng phổi, tổ chức phổi, phế quản, phế nang
- Không thể lấy 2 loại mẫu bệnh phẩm trên, có thể lấy dịch súc họng, dịch ngoáy họng, dịch rử mũi/tỵ hầu

- Mẫu máu (không bắt buộc):

- Bệnh phẩm máu là máu toàn phần giai đoạn cấp và giai đoạn hồi phục
- Thể tích lấy mẫu máu: 3-5ml

- Thời điểm thu thập mẫu:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Bệnh phẩm đường hô hấp trên (dịch tỵ hầu và dịch họng): ngày 0 đến ngày 7 kể từ khi khởi bệnh
- Bệnh phẩm đường hô hấp dưới (dịch nội khí quản): ngày 0 đến ngày 14 kể từ khi khởi bệnh
- Bệnh phẩm máu giai đoạn cấp: ngày 0 đến ngày 7 kể từ khi khởi bệnh
- Bệnh phẩm máu giai đoạn hồi phục: tại ngày 14-21 kể từ khi khởi bệnh hoặc theo chỉ định của phòng xét nghiệm
- Bệnh phẩm là đờm, dịch súc họng, tổ chức phổi, phế quản, phế nang: theo chỉ định của phòng xét nghiệm

Ngoài ra, trường hợp bệnh nhân đã được xác định dương tính vi rút SARS-CoV-2, hoặc người tiếp xúc với bệnh nhân xác định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, mẫu bệnh phẩm được lấy tại những thời điểm theo chỉ định.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

a. Mẫu bệnh phẩm đường hô hấp

- Tăm bông cán mềm và cán cứng vô trùng không phải là calcium hay gỗ, có đầu là sợi tổng hợp
- Đè lưỡi
- Ống ly tâm hình chóp 15ml có nắp vặn, chứa 2-3ml môi trường vận chuyển virus
- Lọ nhựa (ống Falcon 50ml) hoặc túi nilon đê đóng gói bệnh phẩm

b. Mẫu máu

- Bơm tiêm 3ml hoặc 5ml vô trùng, hoặc đầu kim lấy máu chân không
- Ống đựng máu vô trùng (có hoặc không có chất chống đông)
- Dây garo
- Bông, cồn sát trùng

c. Trang phục bảo hộ cá nhân

- Mũ
- Kính bảo vệ mắt
- Khẩu trang y tế chuyên dụng (N95,…)
- Áo quần bảo hộ
- Găng tay

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Bao giày/ủng

d. Đóng gói mẫu bệnh phẩm

- Giấy thấm/gạc có tẩm chất sát trùng
- Thun vòng cao su
- Túi nilon miệng kín (túi zip) (để đóng gói bệnh phẩm)
- Gel đá lạnh
- Thùng chứa mẫu bệnh phẩm (thùng cứng, có nắp đậy kín)

e. Hóa chất sát trùng

- Cồn 70°
- Dung dịch sát trùng khác như Cloramin B 0,5% hoạt tính

f. Dụng cụ khác

- Bút viết thường, bút viết kính
- Phiếu yêu cầu xét nghiệm
- Giấy thấm khô
- Giấy ghi nhãn (tomy 03)
- Giá đựng mẫu (trong trường hợp lấy nhiều mẫu tại cùng 1 địa điểm)
- Túi đựng rác y tế

7. NGUYÊN LÝ

- Bệnh phẩm nghi nghiễm SARS-CoV-2 phải được thu thập bởi các nhân viên y tế đã được đào tạo về chuyên môn và an toàn sinh học.
- Loại mẫu bệnh phẩm thu thập là mẫu bệnh đường hô hấp và mẫu máu.

8. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

8.1. Chuẩn bị trước khi lấy mẫu bệnh phẩm

8.1.1. Chuẩn bị dụng cụ

Trước khi tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm, cán bộ lấy mẫu cần chuẩn bị đầy đủ các vật liệu, dụng cụ bao gồm: dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm, trang phục bảo hộ cá nhân, dụng cụ đóng gói mẫu bệnh phẩm, hoá chất sát trùng, phiếu yêu cầu xét nghiệm… như đã nêu trong mục 6.

8.1.2. Chuẩn bị phiếu yêu cầu xét nghiệm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Chuẩn bị "Phiếu yêu cầu xét nghiệm" theo đúng yêu cầu của phòng xét nghiệm Sinh học phân tử
- Mỗi phiếu yêu cầu xét nghiệm dùng cho 1 bệnh nhân.
- Thông tin về bệnh nhân, mẫu bệnh phẩm cần được điền đầy đủ và rõ ràng vào "Phiếu yêu cầu xét nghiệm".
- Phiếu yêu cầu xét nghiệm phải có xác nhận của đơn vị gửi mẫu (đối với Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế dự phòng/đơn vị yêu cầu xét nghiệm (đối với Bệnh viện Trung ương)

8.1.3. Ghi thông tin bệnh phẩm

Trước khi lấy mẫu, cán bộ lấy mẫu ghi thông tin bệnh nhân lên giấy ghi nhãn (tomy 103) rồi dán lên tuýp MTVC chứa mẫu đường hô hấp và tuýp chứa máu Thông tin bệnh nhân ghi trên tuýp mẫu bao gồm:

- Họ và tên đầy đủ
- Năm sinh/hoặc tuổi
- Địa chỉ (phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

8.2. Lấy mẫu bệnh phẩm

8.2.1. Lấy mẫu bệnh phẩm đường hô hấp

Với mỗi bệnh nhân nghi nhiễm 2019-nCoV, loại mẫu bệnh phẩm thu thập như sau: 01 mẫu máu và 01 mẫu đường hô hấp (hoặc dịch họng + dịch tỵ hầu (trong cùng 1 tuýp MTVC) hoặc dịch nội khí quản)

a. Dịch ngoáy họng

- Yêu cầu bệnh nhân ngồi yên, mặt hơi ngửa, há miệng to
- Dùng dụng cụ đè nhẹ nhàng lưỡi bệnh nhân
- Đưa tăm bông vào vùng hầu họng, miết và xoay tròn nhẹ 3 đến 4 lần tại khu vực 2 bên vùng a-mi-đan và thành sau họng để lấy được dịch và tế bào vùng họng.
- Sau khi lấy bệnh phẩm, que tăm bông được chuyển vào ống chứa 3ml MTVC virus. Đầu tăm bông phải ngập hoàn toàn trong MTVC. Nếu que tăm bông dài hơn ống đựng MTVC thì cần bẻ cán tăm bông cho phù hợp với độ dài của ống
- Đóng nắp tuýp MTVC, xiết chặt.

b. Dịch tỵ hầu

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Yêu cầu bệnh nhân ngồi yên, mặt hơi ngửa, trẻ nhỏ thì phải có người lớn giữ
- Nghiêng đầu bệnh nhân ra sau khoảng 70°, 1 tay đỡ phía sau cổ bệnh nhân.
- Đưa nhẹ nhàng tăm bông vào 1 bên mũi, vừa đẩy vừa xoay giúp tăm bông đi dễ dàng vào sâu khoảng bằng ½ độ dài từ cánh mũi đến dái tai cùng phía.

Lưu ý: nếu chưa đạt được độ sâu như vậy mà cảm thấy có lực cản rõ thì rút tăm bông ra và lấy bên mũi còn lại. Khi cảm thấy tăm bông chạm vào thành sau họng mũi thì dừng lại, xoay tròn rồi từ từ rút tăm bông ra.

- Giữ tăm bông tại chỗ lấy mẫu trong vòng 5 giây để đảm bảo dịch thấm tối đa.
- Từ từ xoay và rút tăm bông ra.
- Đặt đầu tăm bông vào ống đựng bệnh phẩm có chứa MTVC và bẻ cán tăm bông để có độ dài phù hợp với ống chứa MTVC. Que tăm bông sau khi lấy dịch tỵ hầu sẽ được để chung vào ống môi trường chứa que tăm bông lấy dịch ngoáy họng.
- Đóng nắp tuýp MTVC, xiết chặt (có thể bọc tuýp bằng giấy parafin).

Lưu ý: khi lấy mẫu bệnh phẩm dịch họng hoặc dịch tỵ hầu của trẻ nhỏ, đặt trẻ ngồi lên đùi của người lớn giữ trẻ, phần cơ thể và tay của trẻ cần giữ chặt, người giữ trẻ ngả đầu trẻ ra phía sau.

c. Dịch rửa mũi/tỵ hầu

- Gắn ống catheter hút vô trùng vào dụng cụ hút
- Nghiêng đầu bệnh nhân ra sau khoảng 70°
- Nhỏ vài giọt muối sinh lý vô trùng vào trong mỗi bên mũi
- Đưa ống catheter vào mũi (ống nên vào sâu bằng khoảng cách từ cánh mũi đến dái tai)
- Bắt đầu hút 1 cách nhẹ nhàng. Từ từ lấy ống catheter ra, vừa lấy ra vừa xoay nhẹ nhàng
- Cho mẫu vào trong ống chứa môi trường vận chuyển

Lưu ý: súc mũi hầu có thể không thực hiện được cho trẻ sơ sinh

d. Dịch súc họng

- Bệnh nhân được súc họng với 10 ml dung dịch rửa (nước muối sinh lý). Dịch súc họng được thu thập vào cốc hoặc đĩa petri và pha loãng theo tỷ lệ 1:2 trong môi trường bảo quản virus

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

e. Dịch nội khí quản

- Dịch nội khí quản được thu thập đối với những bệnh nhân đang thở máy, đã được đặt nội khí quản. Dùng 1 ống vô trùng hút dịch, đặt theo đường nội khí quản rồi hút dịch theo đường ống đã đặt (khoảng 1 -2ml). Cho dịch nội khí quản vào tuýp chứa MTVC bảo quản vi rút.
- Trong trường hợp không thể lấy được các loại mẫu bệnh phẩm trên của bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2, cán bộ lấy mẫu liên hệ với phòng xét nghiệm Sinh học phân tử của khoa Vi sinh-Bệnh viện đa khoa Đức Giang để có chỉ định về loại mẫu thu thập phù hợp.

8.2.2. Lấy mẫu bệnh phẩm máu (máu tĩnh mạch)

- Để bệnh nhân ở tư thế thích hợp
- Chọn vị trí lấy máu thích hợp, buộc dây garo trên chỗ lấy máu từ 3-5 cm.
- Sát khuẩn vị trí lấy máu bằng cồn 70°, đợi khô.
- Chọc kim qua da vào tĩnh mạch, kéo nhẹ pít tông cho máu tự chảy vào xilanh cho đến khi đủ số lượng máu làm xét nghiệm.
- Tháo dây garo, đặt bông vô khuẩn lên trên vị trí chọc kim để cầm máu, rút kim nhanh.
- Tháo kim ra khỏi bơm tiêm, bơm máu từ từ vào thành ống nghiệm để tránh vỡ hồng cầu (nếu lấy máu có chất chống thì lắc trộn nhẹ nhàng trong 30 giây để máu khỏi bị đông).
- Băng vết chích máu bằng băng cá nhân

<u>Lưu ý</u>: Các loại bệnh phẩm thu thập tại đường hô hấp dưới (dịch nội khí quản, phế nang, màng phổi) phải được phối hợp với các bác sĩ lâm sàng trong quá trình thu thập mẫu bệnh phẩm

8.3. Đóng gói, bảo quản mẫu bệnh phẩm

8.3.1. Đóng gói mẫu bệnh phẩm

Bệnh phẩm trước khi chuyển đến phòng xét nghiệm phải được đóng gói theo quy định của Tổ chức y tế Thế giới (đóng gói 3 lớp):

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Siết chặt nắp tuýp bệnh phẩm đường hô hấp và tuýp bệnh phẩm máu để đảm bảo mẫu không bị đổ ra ngoài, bọc từng tuýp bệnh phẩm bằng giấy thấm sau đó buộc bằng thun vòng cao su

- Đặt 2 tuýp bệnh phẩm: bệnh phẩm đường hô hấp và bệnh phẩm máu của 1 bệnh nhân vào túi nilong miệng kín (túi zip), buộc chặt; hoặc đặt trong hộp có nắp kín).

Trong trường hợp có nhiều mẫu bệnh phẩm: Mỗi mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân (tuýp mẫu bệnh phẩm hô hấp + tuýp mẫu máu) đóng gói trong 1 túi nilon zip, sau đó các túi này được đóng gói chung trong 1 túi nilon zip khác hoặc trong hộp có nắp kín.

- Đặt túi/hộp chứa tuýp bệnh phẩm vào phích lạnh vận chuyển mẫu. Nhiệt độ bảo quản mẫu trong phích lạnh phải được duy trì ở 2-8°C trong suốt quá trình vận chuyển đến phòng xét nghiệm.

8.3.2. Bảo quản mẫu bệnh phẩm

- Mẫu bệnh phẩm đường hô hấp được bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C hoặc -70°C. Mẫu bệnh phẩm được bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C nếu mẫu được chuyển đến phòng xét nghiệm Sinh học phân tử của khoa Vi sinh-Bệnh viện đa khoa Đức Giang trong vòng 48h kể từ thời điểm thu thập mẫu; nếu thời gian dự kiến chuyển đến phòng xét nghiệm Sinh học phân tử sau 48 giờ kể từ thời điểm thu thập mẫu, bệnh phẩm được bảo quản ở nhiệt độ -70^{0}C và sau đó được giữ đông băng trong quá trình vận chuyển đến phòng xét nghiệm

- Mẫu bệnh phẩm máu toàn phần có thể bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C trong 2 ngày. Nếu bảo quản lâu hơn thì các mẫu bệnh phẩm phải được bảo quản -70°C.

8.4. Vận chuyển mẫu bệnh phẩm đến PXN

- Mẫu được vận chuyển đến phòng xét nghiệm Sinh học phân tử trong thời gian sớm nhất có thể, không quá 48h sau khi thu thập.

- Trong quá trình vận chuyển mẫu, cần đảm bảo nhiệt độ bảo quản mẫu trong phích lạnh là 2-8°C, đảm bảo dung dịch MTVC trong tuýp mẫu bệnh phẩm không bị đổ ra ngoài.

- Mẫu bệnh phẩm và Phiếu yêu cầu xét nghiệm phải được gửi đồng thời đến phòng xét nghiệm Sinh học phân tử. Phải đảm bảo thông tin trên Phiếu yêu cầu xét nghiệm trùng với thông tin trên tuýp bệnh phẩm.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Phòng xét nghiệm Sinh học phân tử của khoa Vi sinh-Bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp nhận các mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm SARS-CoV-2, ghi chép vào biểu mẫu BM.01.VS.PCR.01

8.5. An toàn sinh học trong quá trình thu thập, đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm

8.5.1. An toàn sinh học trong quá trình thu thập và đóng gói mẫu bệnh phẩm

Cán bộ thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm phải đảm bảo an toàn sinh học trong quá trình lấy mẫu và đóng gói mẫu bệnh phẩm. Người lấy mẫu phải sử dụng trong phục bảo hộ cá nhân trong suốt quá trình thực hiện.

a.Mặc trang phục bảo hộ cá nhân (trước khi lấy mẫu và đóng gói mẫu bệnh phẩm)

- Trang phục bảo hộ cá nhân được mặc trước khi tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm, đóng gói mẫu bệnh phẩm theo thứ tự sau:

- Mũ
- Kính bảo hộ
- Khẩu trang y tế chuyên dụng (N95)
- Quần và áo bảo hộ
- Bao giày/ủng
- Găng tay – lớp 1
- Găng tay – lớp 2
- Tấm che mặt

Lưu ý: đeo 2 lớp găng tay với mục đích: lớp găng 2 dùng để thao tác khi lấy mẫu bệnh phẩm hô hấp, lớp găng 1 dùng để thực hiện các thao tác sau khi lấy mẫu.

b. Cởi bỏ trang phục bảo hộ cá nhân (sau khi lấy mẫu và đóng gói mẫu bệnh phẩm)

- Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm bệnh phẩm: cởi bỏ găng tay lớp 2
- Sau khi đóng gói mẫu bệnh phẩm, cởi bỏ trang phục bảo hộ cá nhân theo thứ tự sau:

- Áo
- Quần
- Bao giày/ủng
- Kính bảo hộ
- Mũ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khẩu trang y tế chuyên dụng (N95…)
- Găng tay - lớp 1

8.5.2. An toàn sinh học trong quá trình vận chuyển mẫu bệnh phẩm

Que tăm bông dịch họng, dịch tỵ hầu phải được bảo quản trong tuýp chứa MTVC vi rút hô hấp.

- Tuýp chứa MTVC phải là tuýp nhựa, có nắp vặn kín.
- Sau khi lấy dịch họng, dịch tỵ hầu, que tăm bông phải được đưa ngay vào tuýp MTVC
- Trong quá trình vận chuyển mẫu, phải đảm bảo bệnh phẩm không bị rò rỉ hay đổ ra ngoài tuýp chứa.
- Túi nilon đựng tuýp bệnh phẩm phải là túi kín
- Thùng chứa mẫu bệnh phẩm trong quá trình vận chuyển mẫu đến phòng xét nghiệm Sinh học phân tử phải là thùng nhựa hoặc thùng bìa các-tông kín, chịu được va đập

9. XỬ LÝ DUNG CỤ, CHẤT THẢI

- Toàn bộ dụng cụ dùng trong quá trình lấy mẫu phải được khử trùng bằng dung dịch khử trùng.
- Toàn bộ trang phục bảo hộ được cho vào 1 túi nilon chuyên dụng dùng cho rác thải y tế có khả năng chịu được nhiệt độ cao, cùng với các dụng cụ bẩn (sử dụng găng tay và khẩu trang mới)
- Buộc chặt và sấy ướt tại nhiệt độ 120°C/30 phút trước khi loại bỏ cùng với rác thải y tế khác hoặc có thể đốt lại lò đốt rác
- Rác thải phát sinh trong quá trình lấy mẫu được xử lý như rác thải y tế theo quy định

10. QUY ĐỊNH AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm .
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.
- Thực hiện theo đúng nguyên tắc phân loại cấp độ an toàn sinh học đối với nhóm nguy cơ của tác nhân sinh học.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả).
- Việc lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến kết quả sai, cho dù phản ứng thực hiện tốt.
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định.

12. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết định 181/QĐ-BYT về về việc Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"
- Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"
- Quyết định số 468/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 7/8/2020 về việc Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19
- Thông tư 40/2018/TT-BYT quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
- Hướng dẫn tạm thời của tổ chức y tế thế giới về xét nghiệm
- Hướng dẫn của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S CDC)
- Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases. Interim guidance 17 January 2020

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 1

PHIẾU YÊU CẦU XÉT NGHIỆM

1. Thông tin bệnh nhân

1.1. Họ và tên bệnh nhân: .....

1.2. Tuổi: Ngày sinh: ..... /...../ .....

.....Tháng tuổi (< 24 tháng): ..... □ Năm tuổi (≥24 tháng); .....

1.3. Giới tính: □ Nam □ Nữ 1.4. Dân tộc: .....

1.5. Địa chỉ bệnh nhân: .....

Thôn, xóm..... Xã/phường: .....

Quận/huyện:..... Tỉnh/thành: .....

1.6. Họ tên người giám hộ (bố mẹ/người thân, nếu có): .....

Điện thoại: .....

2. Thông tin bệnhphẩm

2.1. Ngày khởi phát: ..... /...../ .....

2.2. Ngày lấy mẫu:...../...../ ..... Giờ lấy mẫu: ..... - .....

Người lấy mẫu: ..... Điện thoại: .....

Đơn vị: .....

2.3. Loại mẫu: ..... số lượng: .....

Loại mẫu: ..... số lượng: .....

Loại mẫu: ..... số lượng: .....

2.4. Yêu cầu xét nghiệm: .....

Đơn vị yêu cầu xét nghiệm: .....

Đơn vị gửi mẫu

(xác nhận của người/đơn vị gửi mẫu)

VIỆN .....

PHÒNG XÉT NGHIỆM .....

Ngày/giờ nhận mẫu: ...../ ...../ ..... -.....Người nhận mẫu: .....

Tình trạng mẫu khi nhận:.....

□ Từ chối mẫu □ Chấp nhận mẫu-Mã bệnh nhân:.....

Ghi chú: .....

.....

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.